·护理实践·

多方言微视频在台州市普通话沟通障碍全身麻醉患者术前宣教中的应用

林芝，王园园，王海红，王晓（通信作者）

浙江省台州医院　（浙江台州　317000）

〔**摘　要**〕**目的**　分析多方言微视频在台州市普通话沟通障碍患者术前宣教中的应用价值。**方法**　选取 2023 年 10—12 月于医院拟行三、四级全身麻醉手术且普通话沟通障碍的患者 208 例。采用随机数字表法分为对照组和观察组，每组 104 例。术前 1 d，对照组使用普通话版宣教微视频对患者进行术前宣教，观察组使用方言版宣教视频。比较两组视频内容掌握程度、状态焦虑量表（S-AI）评分、麻醉操作配合度和患者满意度。**结果**　观察组对麻醉基础知识、术前准备、术中注意事项、术后恢复、常见问题 5 个板块考核评分及总分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；手术当天，观察组 S-AI 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组麻醉操作配合度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组满意度评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论**　多方言微视频比普通话微视频在台州市普通话沟通障碍全身麻醉患者术前宣教中的应用效果更好，对其他地区普通话沟通障碍的患者术前宣教具有一定的借鉴。

〔**关键词**〕多媒体；术前宣教；方言；沟通障碍

〔**中图分类号**〕R614.2〔**文献标识码**〕B〔**文章编号**〕1002-2376（2024）18-0121-04

〔**DOI**〕10.3969/j.issn.1002-2376.2024.18.035

全身麻醉手术在现代医学中发挥着至关重要的作用。术前宣教可以帮助接受全身麻醉手术患者了解手术流程、麻醉方式、相关风险及术后恢复等关键信息，有效减轻患者的术前焦虑和恐惧，提高对手术的信心[1-2]。然而，在多元文化、多方言并存的地区，普通话沟通障碍严重影响了术前健康宣教的效果[3]。浙江省台州市地理位置特殊，保留了较多古越及吴语音。吴语－台州片可细分为 6 个小片，还包括闽南语区和瓯语区[4]。在日常手术诊疗中，许多患者仅掌握地方方言，术前宣教沟通尤为困难。语言障碍导致患者无法全面、深入地理解手术诊疗的目的、流程及重要性，因此在手术过程中更易出现焦虑、不安等负性情绪，增加了手术风险[5]。随着数字媒体和互联网技术的普及和应用，微视频作为一种新颖且高效的信息传播方式，逐渐被广泛应用于患者术前宣教，并取得了良好的效果[6]，但关于多方言版本微视频的术前宣教研究较少。多方言微视频用患者熟悉的方言进行解说，患者可以更全面地诊疗信息，减轻焦虑情绪，从而提高治疗成功率和患者的满意度[7]。基于此，本研究旨在评价多方言微视频在台州市普通话沟通障碍患者术前宣教中的应用价值，现报道如下。

基金项目：2023 年度台州恩泽医疗中心（集团）科研基金一般项目（23EZB11）

收稿日期：2024-04-19

1　资料与方法

1.1　一般资料

选取 2023 年 10—12 月于医院拟行三、四级全身麻醉手术且普通话沟通障碍的患者 208 例。采用随机数字表法分为对照组和观察组，每组 104 例。对照组男 97 例，女 87 例；平均年龄（46.89 ± 13.25）岁；平均受教育年限（13.07 ± 2.93）年；平均体质量指数（body mass index，BMI）（24.33 ± 3.79）kg/m^2；美国麻醉医师协会（American Society of Anesthesiologists，ASA）麻醉手术危险性分级为Ⅰ级 47 例，Ⅱ级 83 例，Ⅲ级 48 例。观察组男 89 例，女 75 例；平均年龄（47.19 ± 12.53）岁；平均受教育年限（13.29 ± 2.81）年；平均 BMI（24.81 ± 3.91）kg/m^2；ASA 分级Ⅰ级 38 例，Ⅱ级 74 例，Ⅲ级 32 例。两组均包括临海、仙居、天台、黄岩、温岭、玉环、三门和椒江 8 大类方言，每类方言 13 例患者。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。

中国知网　https://www.cnki.net

纳入标准：普通话沟通障碍，但使用方言可正常沟通；居住地位于临海、仙居、天台、黄岩、温岭、玉环、三门和椒江 8 大类方言核心区域；年龄 18 周岁以上，且无精神类疾病史；拟行三、四级全身麻醉手术；ASA 分级为Ⅰ～Ⅲ级。排除标准：有听力、视力障碍；患有影响智力的疾病、自身存在智力障碍或精神发育迟缓。

1.2 方法

制作普通话版微视频[8-10]：采用访谈法了解手术患者术前最想了解的手术相关内容。采用协同专家函询法了解医护人员需要手术患者重点了解并掌握的相关知识。撰写易于理解的微视频文本，内容包括 6 个板块。（1）麻醉基础知识。（2）术前准备：强调术前禁食、禁饮的重要性；如何调整心态，缓解焦虑和压力。（3）术中注意事项：描述手术室的环境和设备，解释麻醉过程中的感受，以及可能出现的不适情况和应对方法。（4）术后恢复：详细说明术后麻醉恢复的过程和可能的不适感，提供术后护理和康复的建议，包括疼痛管理、伤口护理等。（5）常见问题与解答：列举并解答患者和家属关心的常见问题，如麻醉对记忆力的影响、术后多久能恢复正常生活等。（6）结尾鼓励：强调麻醉的安全性，鼓励患者保持积极心态，配合医师的治疗和建议。视频制作和剪辑：在合适的拍摄场地选择道具、医学模型，按照剧本拍摄，难以理解的内容制作动画演示，确保每个场景都清晰明了。使用专业的视频剪辑软件进行后期剪辑，添加必要的字幕、动画和音效。视频总时长 5 min。所有配音均由同一名普通话配音人员完成。普通话配音人员入选资格：女性；获得国家执业护士资格证书；获得国家普通话二级证书；口齿清晰，语言流利。

多方言微视频的制作：普通话母版微视频制作完成后，根据台州地区 8 大类方言对母版微视频分别进行配音。方言配音人员入选资格：女性；获得国家执业护士资格证书，工作单位不限；0～18 岁期间在该方言核心区域生长且会说该方言；口齿清晰，语言流利。

术前 1 d，护士陪同患者在安静的环境下使用平板电脑观看宣教微视频。对照组观看普通话版，观察组观看符合患者方言类别的方言版。

1.3 观察指标

（1）视频内容掌握程度：观看视频结束后，护士就视频中涉及的知识点向患者提问，内容包括麻醉基础知识、术前准备、术中注意事项、术后恢复、常见问题 5 个板块。每个板块分别设置 5 个问题，每题 4 分，总分 100 分。根据患者回答情况评分，评分越高表示掌握程度越好。（2）焦虑情况：宣教前和手术当天采用状态焦虑量表（state-anxiety inventory，S-AI）评分[6]评估患者的焦虑情况。S-AI 是状态－特质焦虑问卷（State-Trait Anxiety Inventory，STAI）中的第 1～20 项。其中 10 项为描述负性情绪条目，10 项为描述正面情绪条目。每条计 1～4 分，总分 20～80 分，评分越高表明焦虑越严重。（3）麻醉操作配合度[11]：熟练配合为能够顺利完成麻醉医师、护士所有的指令；基本配合为多次示范或说教后可以完成指令；不配合为不理解并错误执行工作人员的指令。（4）患者满意度：采用自制满意度调查问卷评估，包括宣教内容的清晰度，0～4 分，代表从完全没听懂到完全听懂；方言解说的易懂性，0～4 分，代表从完全没听懂到完全听懂；视频的帮助程度，0～4 分，代表从完全没有帮助到有很大帮助；宣教方式的整体感受，0～4 分，代表从非常不喜欢到非常喜欢。总分 16 分。该问卷的 Cronbach's α 信度系数为 0.872。为避免评价偏倚，视频掌握程度、S-AI 评分和患者满意度均由具备相应方言听说能力的护士评价。

1.4 统计学处理

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，采用 t 检验。计数资料以率表示，采用秩和检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组视频内容掌握程度比较

观察组患者对麻醉基础知识、术前准备、术中注意事项、术后恢复、常见问题 5 个板块考核评分及总分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 1。

表 1 两组视频内容掌握程度比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	麻醉基础知识	术前准备	术中注意事项
对照组	104	10.32 ± 2.10	12.45 ± 2.98	14.89 ± 2.01
观察组	104	18.76 ± 1.89	17.90 ± 3.76	17.34 ± 4.93
t		30.465	11.585	4.693
P		<0.001	<0.001	<0.001
组别	例数	术后恢复	常见问题	总分
对照组	104	13.44 ± 2.87	12.67 ± 2.15	63.45 ± 8.01
观察组	104	17.12 ± 3.68	16.89 ± 3.85	88.01 ± 7.02
t		8.042	9.759	23.516
P		<0.001	<0.001	<0.001

2.2 两组焦虑情况评分比较

宣教前，两组 S-AI 评分差异无统计学意义（$P>0.05$）。宣教后和手术当天，观察组 S-AI 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　两组 S-AI 评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	宣教前	手术当天
对照组	104	55.78 ± 8.90	49.32 ± 9.12
观察组	104	56.12 ± 9.23	37.67 ± 7.89
t		0.270	9.852
P		0.787	<0.01

注：S-AI 为状态焦虑量表

2.3　两组麻醉操作配合度比较

宣教后，观察组围手术期麻醉操作配合度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

表 3　两组麻醉操作配合度的比较 [例（%）]

组别	例数	熟练配合	基本配合	不配合
对照组	104	40（38.46）	48（46.15）	16（15.38）
观察组	104	60（57.69）	36（34.62）	8（ 7.69）[a]

注：与对照组比较，$Z=3.887$，[a]$P=0.004$

2.4　两组宣教满意度比较

观察组患者满意度评分 [（12.63 ± 2.31）分] 高于对照组 [（9.54 ± 1.65）分]，差异有统计学意义（$t=20.135$，$P<0.05$）。

3　讨论

本研究结合了访谈法、专家函询法以及多媒体制作技术，创新性地制作了多方言术前宣教微视频，体现了以患者为中心的服务理念，充分考虑了患者的方言背景和沟通需求，通过临床实践取得了较好临床效益。

本研究结果显示，观察组患者对视频内容掌握程度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。说明多方言微视频宣教提高了患者对手术相关知识的理解和掌握程度。这是因为它采用了患者熟悉的方言解说，宣教更贴近患者日常生活中的沟通习惯。方言的亲切感打破了普通话障碍，降低了手术专业信息带来的陌生感，提高了信息的可理解性和接受度 [8]。此外，本研究视频中的动画演示结合了字幕，通过视听传播，进一步增强了信息的直观性和易懂性，有助于患者更好地理解和掌握手术相关知识。陈婕嫱等 [12] 在术前准备室采用方言视频对微创经皮椎体后凸成形术患者进行术前宣教，发现方言观察组患者对视频内容的掌握程度高于普通话对照组，这与本研究结果一致。本研究结果显示，宣教后手术当天，观察组的 S-AI 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。这说明多方言微视频减轻了患者的术前焦虑和恐惧，提高了患者对手术的信心。因为多方言微视频能够全面、详细地传递手术信息。通过方言解说，患者能更深入地了解手术的目的、流程、可能的风险以及术后注意事项。这种全面的信息传递帮助患者建立了正确的手术预期，减少了因为信息不对称而产生的担忧和焦虑 [1]。同时，方言的亲切感也增强了对患者的心理安慰，提高了其对手术的信心。黄美娜等 [13] 研究认为对普通话沟通障碍的眼科手术患者进行方言沟通有利于缓解患者的围手术期焦虑和抑郁状态，与本研究结果一致。

本研究结果显示，经宣教后观察组的麻醉操作配合度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。这说明多方言微视频的应用提高了患者的麻醉操作配合度，减少了手术过程中的负性情绪，利于降低手术风险。多方言微视频通过详细阐述手术相关知识，让患者更加了解手术过程和麻醉操作的必要性，增强了其对麻醉操作的理解和配合度。从而降低了手术风险。方晓群等 [14] 使用方言视频对眼科患者进行术前宣教，有效提高了围手术期患者的配合程度，与本研究结果一致。本研究结果显示，观察组患者的满意度高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。这说明多方言微视频的应用提高了患者的满意度，增强了医患、护患之间的沟通和信任。多方言微视频不仅为患者提供全面的手术信息，还通过方言解说这种亲切、全面的信息传递方式提高了患者对医护人员的信任和满意度。当患者感受到医护人员的关心和理解时，更有可能对医疗服务和就医体验感到满意 [14]，从而有助于建立和谐的医患关系。李晓琴等 [11] 采用方言视频联合回馈教学的方法对老年全髋关节置换术后患者进行康复指导，获得了较好的患者满意度，与本研究结果一致。

综上所述，在普通话沟通障碍的全身麻醉患者术前宣教中应用多方言微视频，能有效克服语言障碍，提高术前宣教的效果。这种宣教方法体现了以患者为中心的服务理念，充分考虑了患者的方言背景和沟通需求。本研究为多方言地区术前宣教提供了新的思路和方法。

[参考文献]

[1] Zaka S, Khan T, Shaqul Q, et al. Preoperative education improves the preparedness for extubation at emergence from general anaesthesia[J]. J Perioper Pract, 2020, 32(11): 1125-1129.

[2] 杨丽娜 . 方言的文化和社会功能 [J]. 人民论坛，2020（1）：138-139.

[3] 曹志耘 . 论浙江方言文化的保护传承 [J]. 浙江社会科学，2021（2）：118-124，159.

[4] 许帆婷 . 浙江中部吴语比较研究 [D]. 北京：北京大学，2011.

[5] 陈孝春，陈先建，赵淑珍，等 . 医师职业核心素养

（下转第 127 页）

中国知网 https://www.cnki.net

用，与既往研究结果相符。分析原因为，个性化干预期间，护理人员通过详细介绍脑梗死的病因、发病机制及康复计划加强患者的疾病认知，促使患者主动进行康复训练，提高其日常生活能力；通过共情干预安慰和鼓励患者，打消了恐惧心理，通过病友分享治疗经验为患者及家属提供护理指导和信息支持，同时不断反馈问题并及时调整，促进患者保持良好的健康行为、依医嘱行康复锻炼，从而提升了自我适应度，有利于生活质量的提升[12]。本研究结果显示，观察组穿刺点出血率低于对照组（$P<0.05$）。分析原因为，个性化护理中，及时记录输液过程中的情况，给予患者保温措施等，针对并发症采取预防措施，同时联合共情干预倾听患者在治疗时出现的问题，了解其需求和想法，避免了穿刺点出血等不良事件的发生。

综上所述，个性化干预联合共情干预能改善外周静脉留置针输液治疗脑梗死患者的遵医行为与心理状态，有利于神经功能的恢复及生活质量的提升，减少了穿刺点出血的发生。

［参考文献］

［1］张萍，杨涛，杨焕芝，等 . 强化康复干预联合共情护理对脑梗死患者心理状态、治疗依从性及生活质量的影响 [J]. 国际护理学杂志，2021，40（1）：48–51.

［2］刘倩 . 脑梗死患者的个性化护理干预及对康复功能影响分析 [J]. 黑龙江医药科学，2019，42（4）：169，171.

［3］《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》发布 [J]. 中华医学信息导报，2018，33（19）：10.

［4］高慧英，王春红 . 焦虑及抑郁自评量表的临床效度 [J]. 中国保健营养（下旬刊），2013（9）：4955–4956.

［5］李凌江 . 中国成人生活质量评估工具的制定与应用研究 [Z]. 长沙：中南大学湘雅二医院 . 2008.

［6］孙伟平 . NIHSS 评分 [C]// 广东省医学会 . 广东省医学会第十八次神经病学学术会议暨第八届粤港澳神经病学学术会议论文集 . 广东省医学会神经病学分会，2016:141–144.

［7］张磊，刘建民 . 改良 Rankin 量表 [J]. 中华神经外科杂志，2012，28（5）：512.

［8］崔静舒，梁洁，刘春兰，等 . 个性化干预对康复期脑卒中患者的影响 [J]. 广东医科大学学报，2019，37（4）：492–495.

［9］刘春蕾 . 脑梗塞患者的个性化护理干预及对康复功能影响分析 [J]. 世界最新医学信息文摘（连续型电子期刊），2019，19（54）：328，331.

［10］黄敏 . 个性化护理干预措施对脑梗死偏瘫患者神经功能及认知功能的影响 [J]. 吉林医学，2023，44（2）：538–541.

［11］王延新 . 老年脑梗死临床实施共情护理对患者不良情绪及预后效果的影响分析 [J]. 中国保健营养，2019，29（30）：222.

［12］王忠艳 . 共情护理联合康复护理对脑梗塞患者心理状态及治疗依从性的影响 [J]. 中国冶金工业医学杂志，2023，40（4）：464–465.

（上接第 123 页）

视阈下的医患沟通障碍分析 [J]. 温州医学院学报，2021，51（5）：428–431.

［6］詹也男，付晓华，赖茂珍，等 . 微视频扫码用于脑血管病介入术患者健康教育 [J]. 护理学杂志，2022，37（3）：10–12，38.

［7］罗静，曹影婕，眭文洁，等 . 微视频联合情境体验健康教育方案在空肠造瘘带管出院患者中的应用 [J]. 中华护理杂志，2018，53（12）：1478–1481.

［8］陶艳玲，苏涛，何万巧，等 . 基于 Delphi 法构建临床护士危重症护理必备技能微课资源的课程内容指标 [J]. 全科护理，2021，19（31）：4345–4348.

［9］姜占波，王春红，刘雪融 . 基于 Swanson 关怀理论的癌症患者心灵照护方案关键要素的构建 [J]. 中国实用护理杂志，2020，36（6）：449–454.

［10］翁慧，吴德全，翟玲玲，等 . 基于德尔菲法构建食管癌围手术期健康教育路径 [J]. 中国健康教育，2020，36（1）：61–65.

［11］李晓琴，胡桂花，沈文云，等 . 方言视频联合回馈教学在老年全髋关节置换术后康复中的应用 [J]. 护理学报，2019，26（24）：53–56.

［12］陈婕嫱，徐艳，谢小冬，等 . 术前准备室方言视频宣教在老年脊柱骨折患者 PKP 术中的应用 [J]. 现代实用医学，2021，33（2）：216–217.

［13］黄美娜，陈浙一，陈彩芬，等 . 基于方言的沟通障碍对眼科手术安全影响及解决措施的质性研究 [J]. 中国实用护理杂志，2018，34（25）：1952–1956.

［14］方晓群，连玉，张宇，等 . 基于方言的沟通障碍对“健康快车”患者健康教育的问题分析与对策 [J]. 眼科学报，2018，33（3）：191–194.

中国知网 https://www.cnki.net